Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Viamão

Rua Bento Gonçalves, 90 - Bairro: Centro - CEP: 94415700 - Fone: (51)3098-5599 - Email: frviamao2vciv@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5017219-90.2022.8.21.0039/RS

REQUERENTE: JESSICA CASTILHO MILIOLI
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VIAMÃO / RS
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

JESSICA CASTILHO MILIOLI, ingressa contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e o **MUNICÍPIO DE VIAMÃO,** todos qualificados nos autos, com uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência. Segundo laudo médico, é portadora de "Dermatite atópica grave, Eritrodermia, Corticoterapia crônica - CID L.20.9". Em razão de tal patologia, necessita de forma urgente do medicamento Dupilumabe, injeção 300mg, a cada 2 semanas, com indução 600mg SC, após 300mg SC, semanas alternadas. Aduzindo que o direito à saúde é dever do Estado, nos termos dos arts. 196 e 227 da CF/88, postula seja o réu compelido, inclusive em antecipação de tutela, a disponibilizar o medicamento. Com pedido de assistência judiciária gratuita. Dá à causa o valor de R$ 224.880,00 (duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais).

O e-NATJUS lança nota técnica (evento 16, NOTATEC1).

O juízo indeferiu o pedido liminar (evento 18, DESPADEC1).

Citados o réu, que contestou, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assinalando, de acordo com o Tema 793 do STF, a necessidade de inclusão da União na ação, com a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CF/88, reiterando, no mérito, o não atendimento do caso ao Tema 106 do STJ. Pugna que a prescrição do medicamento seja balizada pela denominação comum brasileira, nos termos do art. 3º da Lei 9787/99. Diz ser descabida a condenação do Estado no ônus sucumbencial, quanto aos honorários pela confusão entre credor e devedor, patrocinada a ação pela Defensoria Pública do Estado, e quanto às custas processuais, pela isenção legal prevista no art. 11 da Lei Estadual 8.121/85, com a redação da Lei Estadual 14.634/2014 (evento 25, CONT1).

Por sua vez, sendo que o MUNICÍPIO DE VIAMÃO argui a incompetência do Juízo, o chamamento ao processo e a denunciação à lide, diante da partilha das responsabilidades entre os entes públicos gestores do SUS, e a violação do princípio constitucional da isonomia, referindo que o fármaco tem alto custo, que não tem previsão orçamentária pelo Município, bem como a ausência de responsabilidade para o custeio, postulando a acolhida das preliminares e a improcedência da ação (evento 30, CONT1).

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção ao feito (evento 69, PROMOÇÃO1).

II - RELATÓRIO

PRELIMINARES. TEMA 793.

É de ser afastada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Viamão para processar e julgar esta causa, cujo valor foi fixado em R$ 224.880,00 (duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais), acima dos 60 (sessenta) salários-mínimos estabelecidos no art. 2º da Lei 12.153/09, confirmando-se a competência do juízo.

Não é caso de remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a responsabilidade dos entes públicos é solidária, conforme arts. 6º, 23, II, e 30, VII, da CF/88 e art. 241 da Constituição Estadual, cabendo somente o repasse posterior de verba compensatória pela União relativamente ao tratamento.

Sucede que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema repetitivo n.º 793 (RE n.º 855178 RG), 16.03.2015[1], ao contrário do que alega a parte contestante, **não criou a obrigação de chamamento da União à lide, tendo reafirmado tão só a responsabilidade solidária dos entes públicos, na fixação da tese de que a responsabilidade em demandas que envolvem o direito à saúde é solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.**

Na sequência, em sede de complementação, em embargos de declaração, julgado em 23.05.2019, com a publicação do acórdão em 16.04.2020, restou sedimentado:

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento*

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ED no RE 855.178 se, Relator(a): Min. Luiz FUX, julgado em 23.05.2019, public 16.04.2020) (grifei)

Logo, não há falar em afastamento da solidariedade dos entes públicos, tendo a Corte Suprema apenas reafirmado a tese anteriormente defendida de que:

> *"eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles".*

No sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TEMA REPETITIVO Nº 793 DO STF. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. MIELOMA MÚLTIPLO (CID N18). BORTEZOMIBE 3,5MG. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELO ENCAMINHAMENTO DA AUTORA AO CACON/UNACON OU O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO POSTULADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema repetitivo nº 793 (RE nº 855178), não criou a obrigação de se chamar a União à lide. Para a devida aplicação do referido precedente deve ser analisada a matéria ali em discussão, ou seja, se a União era legítima ou não para figurar no polo passivo. Desta forma, a Suprema Corte, ao julgar o Tema repetitivo nº 793, apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório a Corte Suprema reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. 2. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico. 3. A ausência de inclusão dos medicamentos em listas prévias, quer referente a remédios considerados excepcionais, quer relativos à rede básica, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados. Da mesma maneira, a forma de organização do SUS não pode obstaculizar o fornecimento de medicamentos. 4. Comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever dos entes públicos encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá aos réus custearem o tratamento da parte autora. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083790402, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020)*

O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

O processo, cujo mérito envolve questões fáticas e jurídicas, contendo documentos suficientes à solução da lide, impõe ser julgado antecipadamente, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Cumpre ser observado que o réu não impugnou na respectiva peça de contestação a hipótese diagnóstica da autora, acometida pela patologia classificada como "Dermatite atópica grave, Eritrodermia, Corticoterapia crônica - CID L.20.9".

Logo, é totalmente despicienda, no caso concreto, a realização da prova pericial, sobretudo porque não há litígio entre as partes relativamente ao diagnóstico e à eficácia da medicação requestada, **fatos estes tidos como incontroversos**.

MÉRITO

PATOLOGIA DA PARTE AUTORA. O FÁRMACO.

O medicamento postulado na petição inicial Dupilumabe, injeção 300mg, a cada 2 semanas, com indução 600mg SC, após 300mg SC, semanas alternadas, tem indicação aprovada para o tratamento de "Dermatite atópica grave, Eritrodermia, Corticoterapia crônica - CID L.20.9".

No caso específico, veio aos autos a nota técnica do e-NATJUS, que aconselhou o uso dos medicamentos ante a conclusão de existência de "elementos sustentando o uso de Dupilumabe, no presente caso".

O LAUDO juntado com a inicial confirma a patologia e a necessidade da medicação (evento 1, LAUDO9, evento 1, LAUDO10).

TEMA 106 DO STJ.

Para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, há necessidade de atendimento ao Tema 106 do STJ, cuja tese firmada é a seguinte:

> *A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.*

Pelo laudo juntado, atendendo ao Enunciado 12 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ, expressa-se a inefetividade dos medicamentos disponibilizados pelo sistema SUS, inexistindo outro fármaco que lhe possa substituir.

Confira-se:

> *A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico, que indique e descreva as normas éticas, sanitárias e farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com*

base na medicina de evidências (STJ, Recurso Especial nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção Cível – julgamento repetitivo dia 25.04.2018 – Tema 106), (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária finalizada no dia 19 de abril de 2023, referendou, por unanimidade, decisão liminar do Ministro Gilmar Mendes, que estabeleceu os parâmetros da atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema n.º 1.234:

> *"(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)."*

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 12 de abril de 2023 (acórdão publicado em 18 de abril de 2023), ao julgar o Incidente de Assunção de Competência n.º 14, pacificou o entendimento de que:

> *"(...) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080 /1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal."*

Ademais, a documentação juntada demonstra a ausência de condições financeiras da parte autora.

Como se depreende do acórdão, cuja ementa abaixo se transcreve, o medicamento DUPILUMABE tem sido utilizado no tratamento médico da patologia:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. DIREITO INTERTEMPORAL E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1234 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame: Apelação interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando-o ao fornecimento do medicamento "dupilumabe" para tratamento de dermatite atópica e asma. II. Razões de decidir: As orientações firmadas no Tema 1234 deverão ser observadas para as demandas que ainda não foram sentenciadas quando da publicação da sua ata de julgamento (19.09.2024), sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa. Ao caso, portanto, aplicam-se as premissas fixadas pela Corte Constitucional por ocasião do deferimento da tutela provisória em caráter incidental, bem como no Tema 106 do STJ. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa revelou-se desproporcional. Adotou-se o critério de equidade para reduzi-los. III. Tese de julgamento: 1. Para processos já sentenciados antes do julgamento do Tema 1234 do STF, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ, em conjugação com as premissas definidas pelo STF por ocasião do deferimento da tutela provisória incidental. 2. O critério de equidade é aplicável à fixação de honorários advocatícios em causas com proveito econômico inestimável ou irrisório. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50302260820238210010, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Julgado em: 10-01-2025).*

De conseguinte, se afigura inadmissível que os réus se recusem a fornecer o tratamento, sob o argumento da ausência de protocolo ou do alto custo medicação, havendo recomendação para a patologia cuidada nos autos através de laudo médico fundamento.

A prescrição do medicamento constitui ato médico que, em razão dessa assertiva, não pode sofrer direcionamento ou restrição, seja de natureza legal ou administrativa.

O alto custo do medicamento ou a circunstância de não constar das listas, ou protocolos administrativos de dispensação pelo SUS não exime os entes demandados de fornecê-lo.

Nesse sentido:

> *ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 273 DO CPC. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há confundir decisão contrária aos interesses da parte com inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.* ***3. O argumento de que a medicação solicitada pelo autor "não consta da lista medicamentos pertencentes ao denominado Grupo 02, de responsabilidade dos Estados e Distrito Federal, segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.981/2009, que aprova o componente especializado de assistência farmacêutica (distribuição de medicamentos do SUS)," também não encontra amparo neste Tribunal, pois não tem a faculdade de eximir o Estado da obrigação, imposta pela ordem constitucional, de assistir aqueles que, como a recorrida, não dispõem de recursos financeiros para custear o tratamento da própria saúde.****4. Quanto à apontada falta de verossimilhança de alegações a sustentar o deferimento de tutela antecipada, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos de que trata o artigo 273 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela antecipada, enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.6. Agravo Interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1606408/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) – grifei*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON COM METÁSTASES HEPÁTICAS. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: CETUXIMABE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. - ***O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.*** *- Presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o deferimento do pleito antecipatório. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES CASO DESCUMPRIDA A DECISÃO JUDICIAL. - Há concordância majoritária sobre a possibilidade de bloqueio de valores junto às contas dos entes públicos, caso os entes públicos se neguem a cumprir a decisão e assegurar o tratamento adequado. Aplicação direta do § 3º do art. 461-A e do § 5º do art. 461, ambos do Código de Processo Civil. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. - Análise do pedido de manifestação da parte autora sobre a possibilidade de substituição da medicação por substâncias alternativas disponíveis na rede pública de saúde por esta Corte que ocasionaria supressão de um grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068529304, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 04/03/2016) – grifei.*

Salienta-se que a ação foi ajuizada anteriormente ao TEMA 1234 do STF e que à data do ajuizamento da presente demanda, a jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 106 do STJ, amparava o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando evidenciada a necessidade do tratamento e a ineficácia de alternativas oferecidas pelo sistema público.

NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO SEMESTRAL DOS LAUDOS COM PROVA DE VIDA.

Como se trata de medicamento de alto custo em patologia de alta complexidade, deve a parte autora, **na falta comprovada da medicação em estoque**, apresentar atestados médicos atualizados que comprovem a necessidade e a eficácia do fármaco, conforme a fase da doença, no tratamento em progressão, presumindo-se a desistência no cumprimento em caso de não atendimento.

No sentido, o Enunciado n.º 02 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde de 18.03.2019.

ENUNCIADO n.º 02

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Desta forma, tendo em vista a necessidade e urgência na realização do tratamento médico pela parte autora, que corre risco de morte pela gravidade da doença, o fornecimento do medicamento solicitado pelos réus é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO:

(i) JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento Dupilumabe, injeção 300mg, a cada 2 semanas, com indução 600mg SC, após 300mg SC, semanas alternadas, enquanto se fizer necessário, pelo princípio ativo, de acordo com a denominação comum brasileira, nos termos do art. 3º da Lei n.º 9.787/99, devendo ser fornecida, em cada disponibilização, a quantidade suficiente para 03 (três) meses de tratamento.

(ii) DECLARO, ainda, para nova solicitação de bloqueio, na falta comprovada da medicação em estoque, deverá a parte autora a apresentar relatório médico circunstanciado, com validade para seis meses, nos termos do Enunciado 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, acerca da necessidade de manutenção do tratamento, com <u>prova</u> <u>de</u> <u>vida</u>.

Sucumbentes, os entes públicos réus são isentos do pagamento da taxa única, mas arcarão com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), usando-se por analogia o art. 85, §8º, do CPC, já que muito alto o valor da ação, quantia que deverá ser dividida pela metade para cada réu. Suspensa a exigibilidade forte no artigo 98, § 3º, do CPC.

É caso de remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, e da Súmula 490 do STJ, já que a condenação é superior a 100 (cem) salários-mínimos.

Registros e intimações eletrônicas agendadas.

Com o trânsito em julgado, efetue-se a baixa definitiva.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO EDEL LIGORIO FAGUNDES, Juiz de Direito**, em 21/01/2025, às 15:34:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10075175245v5** e o código CRC **232cf6b9**.

---

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) ↩